株式会社 Uchi care　職員研修

訪問看護・居宅介護支援における腰痛予防研修

作業条件の評価と、方法を選ぶ根拠を学ぶ

対象　看護師・理学療法士・作業療法士・ケアマネジャー・事務職

目的　職員自身の健康保持・増進と、業務に伴う腰痛の予防

時間　30 〜 40 分（講義・事例検討・理解度確認）

1 **なぜ**
負担が生じる仕組み

2 **何を**
評価するか

3 **どの根拠で**
方法・用具を選ぶか

本資料は一般的な予防教育です。個別の診断・治療・就業判断は医師等にご相談ください。

なぜ今、腰痛予防を「判断の根拠」から学ぶのか

職場の腰痛の現状（国内）

約 6 割

休業 4 日以上の業務上疾病に占める業務上腰痛の割合

最多

業種別の業務上腰痛件数で保健衛生業が最も多い

- 2018 ～ 2019 年の労働者死傷病報告の分析。休業 3 日以下や未報告の腰痛は含まれない
- 施設・病院のデータが中心で、訪問看護にそのまま当てはめることはできない

この研修で説明できるようになること

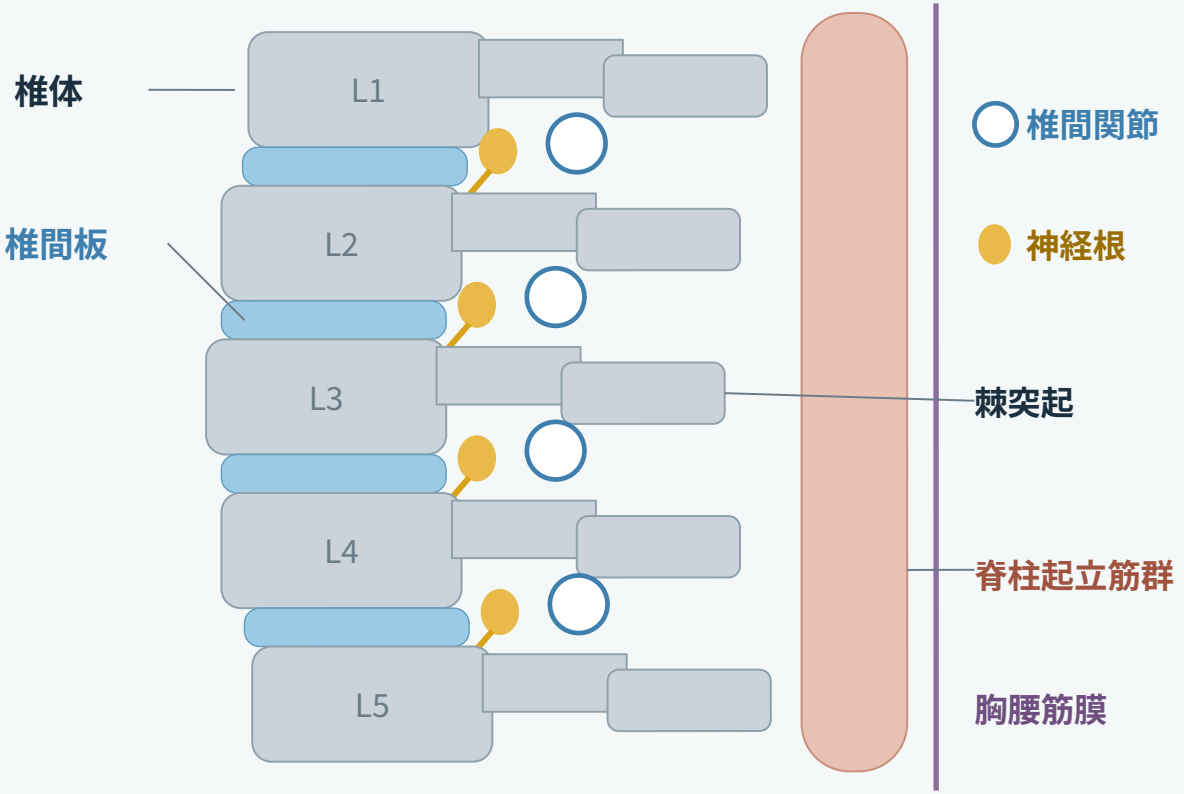
1. 腰痛の構造的・心理社会的な成り立ちと、画像所見の解釈の限界
2. 荷重・距離・時間・頻度・支持から腰部負担を評価する方法
3. 場面ごとの評価項目と、方法・福祉用具を選ぶ根拠と限界
4. 慢性化に関わる要因と、受診・医療相談が必要なサイン

健康経営の取組の一つとして実施します。本研修のみで認定されるものではなく、作業環境・体制の改善と組み合わせて効果を考えます。

出典：岩切一幸ほか . 産業衛生学雑誌 2022;64(6):354-366 ／厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針」 (2013) ／経済産業省「健康経営優良法人認定制度」

腰部を支える構造と、それぞれの役割

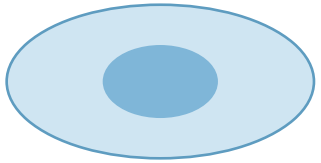
腰椎の側面（概念図：左が前、右が後ろ）



形・比率・位置は説明用に簡略化しています

構造	主な役割	負担がかかりやすい条件（例）
椎間板	髄核と線維輪から成り、荷重を分散し動きを許す	前屈しながらの荷重、長時間の同じ姿勢
椎間関節	左右一対で、動く方向を制御する	反らす・ねじる動き、ねじりながらの荷重
筋・筋膜	姿勢を保ち、動作の力を生む	静的保持による疲労、急な負荷
神経根	椎間孔から出て下肢へ向かう	圧迫や炎症で下肢痛・しびれ

椎間板を上から見た断面

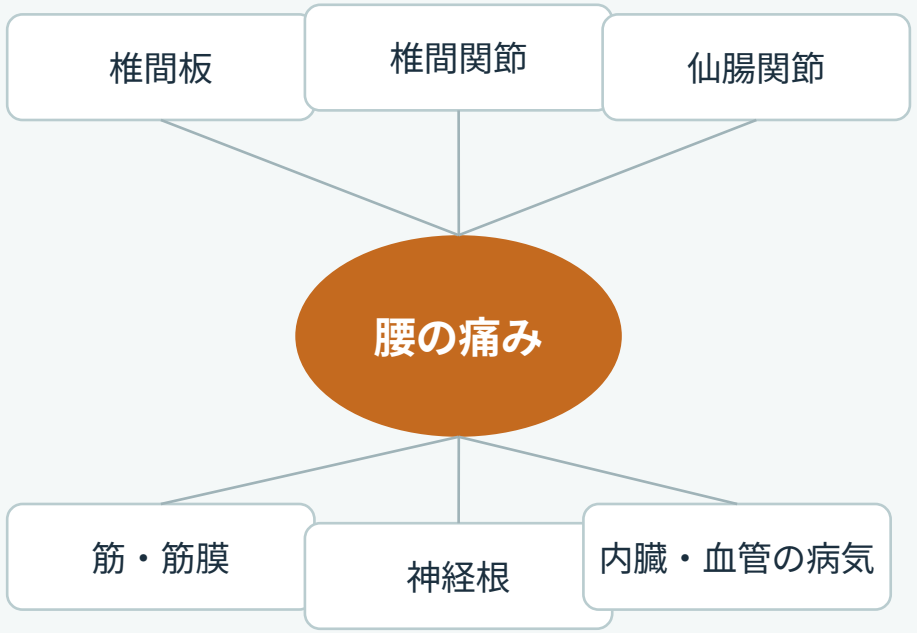


中心：髄核（水分の多いゲル状）
外周：線維輪（層状の線維）

出典：厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針及び解説」(2013)／日本整形外科学会・日本腰痛学会「腰痛診療ガイドライン 2019」

痛む場所だけでは、原因となる組織は特定できない

同じ「腰の痛み」に関わりうるもの



＋ 痛みを処理する神経系の感受性、睡眠・ストレスなども痛みの感じ方に影響

分類	考え方	例・補足
特異的腰痛	原因となる病態を特定できる	椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症、圧迫骨折、感染、腫瘍など
非特異的腰痛	単一の原因を特定できず、神経症状を伴わない	割合は診断の方法・医療体制で異なる（国内外で報告に差）

有症期間による分類（腰痛診療ガイドライン 2019 ）

急性
4 週未満

亜急性
4 週〜 3 か月未満

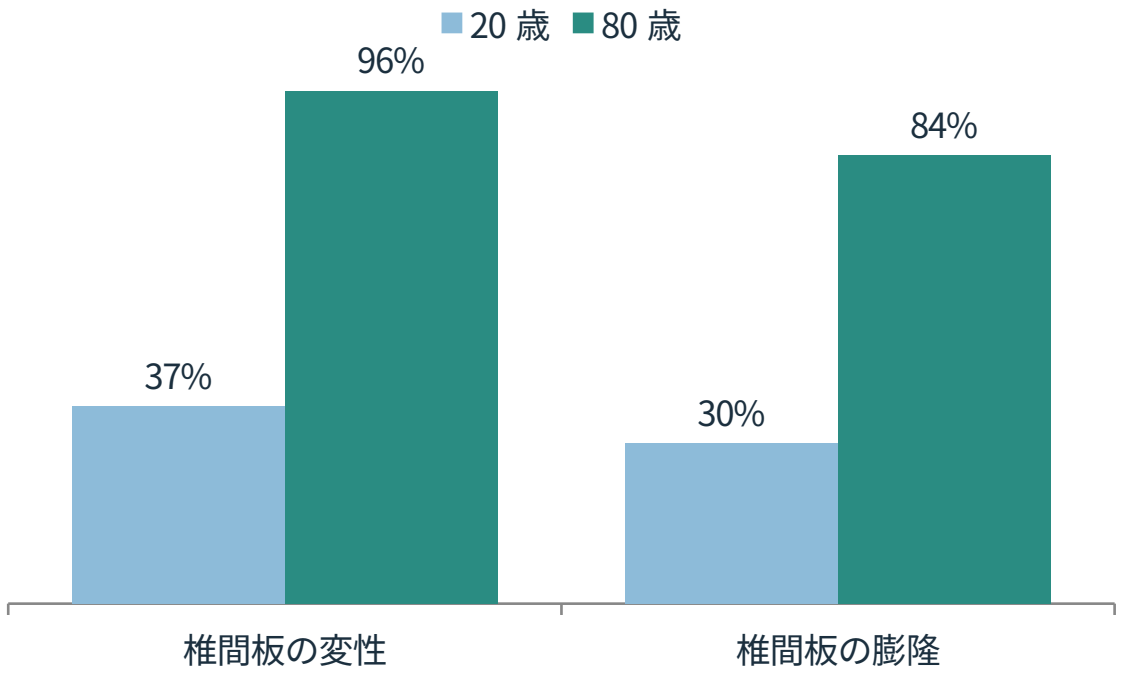
慢性
3 か月以上

期間で区切るのは、経過の見通しと評価・対応の重点が変わるためです。慢性腰痛では、組織の状態だけでなく心理・社会的要因の影響をより重視します。

出典：日本整形外科学会・日本腰痛学会「腰痛診療ガイドライン 2019 」／ Hartvigsen J et al. Lancet 2018;391:2356-67 ／ Suzuki H et al. PLoS One 2016;11:e0160454

画像の変化＝痛みの原因、ではない

症状のない人の CT ・ MRI にみられる所見の割合（推定値）



33 研究・無症状者 3,110 人の系統的レビュー。年齢とともに所見の割合は上がる

腰痛に関わる要因（腰痛予防対策指針の分類）

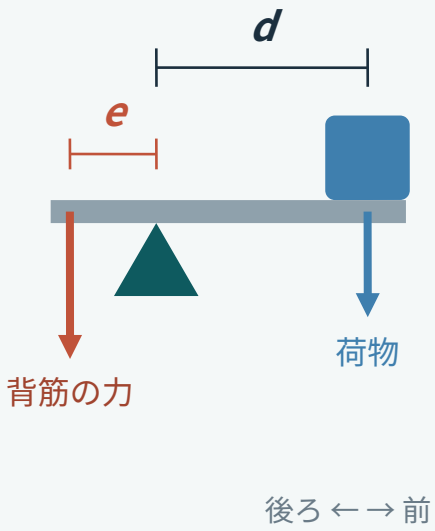
動作要因	抱え上げ、前屈・ひねり、静的姿勢、急な動作
環境要因	狭い空間、作業面の高さ、床・段差、寒冷、照明、振動
個人的要因	年齢、体格、既往症・基礎疾患、家庭での育児・介護の負担
心理・社会的要因	支援不足、対人トラブル、仕事の要求度、休みにくさ

職場の腰痛で単一の要因だけが関わることは稀。複数の要因が重なって発生・悪化する

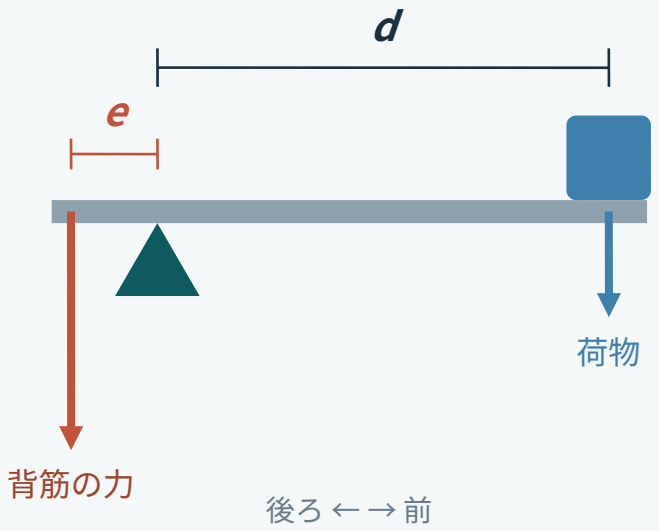
出典： Brinjikji W et al. AJNR 2015;36:811-6 ／厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針及び解説」 (2013)

荷物が身体から離れるほど、腰の筋が出す力は大きくなる

A　荷物を身体に近づけて持つ



B　荷物が身体から離れている



矢印の長さは大小関係の模式であり、実測値ではありません

これは考え方を示す模型です。実際の腰部負荷は、ずれの力・動きの速さ・筋の同時収縮・個人差で変わり、この式から数値は求められません。

釣り合いの簡略モデル

背筋の力 × e
＝ 荷物の重さ × d
＋ 上半身の重さ × その距離

- e（背筋から支点までの距離）は短く、変えにくい
- d が長くなるほど、釣り合うための背筋の力が増え、腰椎を押しつぶす力も増える
- 前屈すると上半身の重心も前に出て、荷物がなくても負担が増える

出典：厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針及び解説」別紙Ⅰ（2013）／ Waters TR. Am J Nurs 2007;107(8)

姿勢の「良し悪し」ではなく、作業条件の組み合わせで評価する

評価する条件	負担が増える方向	なぜ負担が増えるのか
荷重と距離	重い・身体から遠い・つかみにくい	回転させる力（モーメント）が増え、背筋の力と圧縮力が増す
姿勢	前屈＋回旋の組み合わせ、反らしながらのひねり	椎間板・椎間関節に負荷が集中しやすく、筋も不利な長さで働く
時間（静的保持）	同じ前屈姿勢を保ち続ける	筋の持続的な収縮で血流が妨げられ、疲労がたまる
頻度（反復）	回数が多い・休止が短い	1 回は軽くても負荷が積み重なり、回復が追いつかない
支持の有無	手・膝・前腕で支えられない	体重を支える経路がなく、腰部だけで上半身を支える
動きの速さ・予測	急な動き、相手の不意の動き	筋の反応が遅れ、想定外の負荷がかかる

同じ「前屈」でも負担は変わる（例）

負担が大きくなる条件

支えなし／数分間保持／
毎回の訪問で反復／
利用者の体を手前に引き寄せる力を出す

負担が小さくなる条件

ベッド柵や膝で支える／
短時間で姿勢を戻す／
作業を分けて合間に姿勢を変える

→ 姿勢・荷重・時間・頻度・支持をセットで記録して比較する

出典：厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針及び解説」 (2013) ／ Wilke HJ et al. Spine 1999;24:755-62

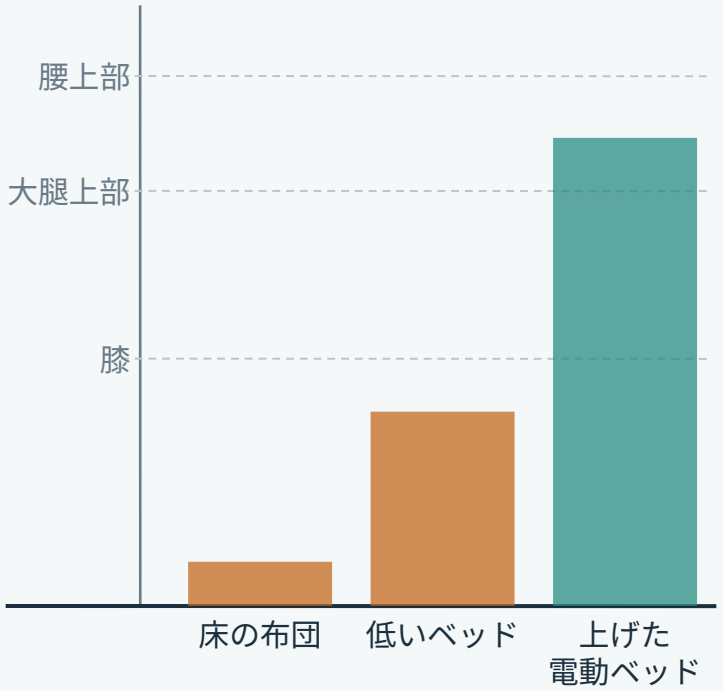
移乗・体位変換：人を「持ち上げない」方法を先に検討する

	① ベッドと車いすの移乗	② 体位変換・ベッド上の位置調整
負担が生じる理由	• 利用者の体重を身体から離れた位置で受け止め、持ち上げ・回旋が同時に起こる。 • 相手が急に動くと予測できない負荷が加わる。	• 低いベッドで前屈し、手前に引き寄せる・上方へずらす動作で、摩擦に逆らって大きな力を出す。 • 前屈＋回旋になりやすい。
評価項目	• 座位保持・立位保持・協力と理解の程度 • 体格差 • 車いすの肘掛け・フットサポートが外せるか • ベッドの高さ調整・周囲のスペース	• ベッドの高さ • ベッドの両側から作業できるか • 寝具の滑りやすさ • 皮膚の脆弱性・褥瘡 • 利用者が膝を立てる・柵を握るなど協力できるか
対策を選ぶ根拠	• 指針は全介助の人力による抱え上げを原則行わず、リフト等を使うとしている。 • 座位が保てればスライディングボード、立位が保てれば立位補助機器を含めて検討。	• スライディングシートは摩擦を減らし、持ち上げる力を水平に滑らせる力に置き換える。 • ベッドを上げて身体に近づくと前屈と d が減る。

出典：厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針及び解説」別紙IV (2013)

清拭・排泄ケア・処置、床や低いベッド：作業面の高さが鍵

作業面の高さと身体の目安



位置関係は目安で個人差があります

	③ 清拭・排泄ケア・創傷処置	④ 床の布団・低いベッド
負担が生じる理由	• 前屈したまま細かい手作業を続ける静的保持。 • 片手で体を支え、反対の手で処置する非対称姿勢。	• 作業面が膝より低く、強い前屈か膝つき・しゃがみが避けられない。 • 立ち上がりの反復も加わる。
評価項目	• 処置の所要時間 • ベッドの高さと幅 • 物品の配置（手の届く範囲か） • 照明 • 利用者が側臥位を保てるか	• ベッド導入の可否と利用者・家族の意向 • 膝つきできる床か • 職員の膝・股関節の状態 • 作業時間と回数
対策を選ぶ根拠	• ベッドを上げて前屈を減らし、物品を手前に置いて d を短くする。 • 長い処置は区切って姿勢を戻す。	• 指針は前屈・中腰を膝つきに置き換え、体を支えることを示す。 • 布団では膝パッド等で膝を保護する。 • ベッド導入は意向を尊重して相談する。

出典：厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針及び解説」本文 2(2) ・別紙III・別紙IV (2013)

入浴・狭い場所、医療機器のある利用者：環境と手順を先に整える

	⑤ 入浴介助・狭い場所での介助	⑥ 医療機器・チューブ類がある利用者
負担が生じる理由	• 浴室・トイレは狭く、正面に立てず回旋が増える。 • 滑りやすい床、濡れによる冷え、高温多湿による疲労も重なる。	• ルートを気にして身体から離れた位置で無理な姿勢を続けやすい。 • 体位変換時に機器・チューブを片手で保持し、非対称な姿勢になる。
評価項目	• 作業空間の広さと職員の立ち位置 • 手すり・シャワーチェア・浴槽台の有無 • 床の滑りやすさ • 湯温と室温 • 利用者の立位・座位の安定性	• 機器とルートの位置・長さの余裕 • 事故抜去のリスク • 作業前に機器を移動できるか • 必要な人数（看護師・家族等の協力者）
対策を選ぶ根拠	• 指針は狭い空間・滑りやすい床・寒冷を腰痛の環境要因とする。 • 正面で作業できる立ち位置を確保し、福祉用具で利用者自身が身体を支えられるようにする。	• 機器とルートの配置を作業前に整えると、動作中の不自然な姿勢と急な動きを防げる。 • 手順に「ルート確認」を組み込み、人数は利用者の状態で決める。

出典：厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針及び解説」本文 3 ・別紙IV (2013)

用具は「どの力を、何に置き換えるか」で選ぶ

用具	置き換える力・役割	適応の目安（利用者側）	確認したい条件・注意
リフト（床走行式・据置式など）	持ち上げる力そのものを機械に任せる	座位・立位の保持が難しい、全介助	スペース・吊り具の適合・皮膚状態・操作の習熟
スライディングボード	座ったまま横に滑って移る。持ち上げを水平移動に置き換える	座位を保てる。前傾・横移動に協力できる	跳ね上げ式肘掛けの車いす、座面の高さをそろえる
スライディングシート	摩擦を減らし、ベッド上でずらす・向きを変える力を小さくする	ベッド上の移動・体位変換が必要	敷き込み方、皮膚のずれ、使用後に抜き取る
立位補助機器（スタンディングマシーン等）	立ち上がりと立位保持を機器が支える	立位をある程度保持でき、指示を理解できる	下肢の支持性、膝・足部の状態、機器の適合

個々の製品の操作方法は、取扱説明書と実技指導で習得します。本研修は「どの用具を、なぜ選ぶか」の考え方を扱います。

出典：厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針及び解説」別紙IV (2013)

適応は複数の条件で決まり、用具にも限界がある

移乗方法を考える順序（一例）

1. **利用者の状態**
   座位・立位の保持、理解と協力、痛み、皮膚の状態、体格
2. **使える用具と環境**
   車いすの種類、ベッドの高さ、スペース、床、用具の有無
3. **人の条件**
   職員の健康状態（腰痛の有無）、習熟度、人数、家族の協力
4. **方法の選択と記録**
   手順・用具・人数を対象者ごとに決め、状態が変われば見直す

知っておきたい限界

用具があれば安全とは限らない

適合しない用具・不慣れな操作・準備の手間で、かえって不自然な姿勢や転落リスクが生じることがある

二人介助でも腰部負担は残る

1 人あたりの重さは減っても、前屈・中腰や身長差による不均等な負荷は残る

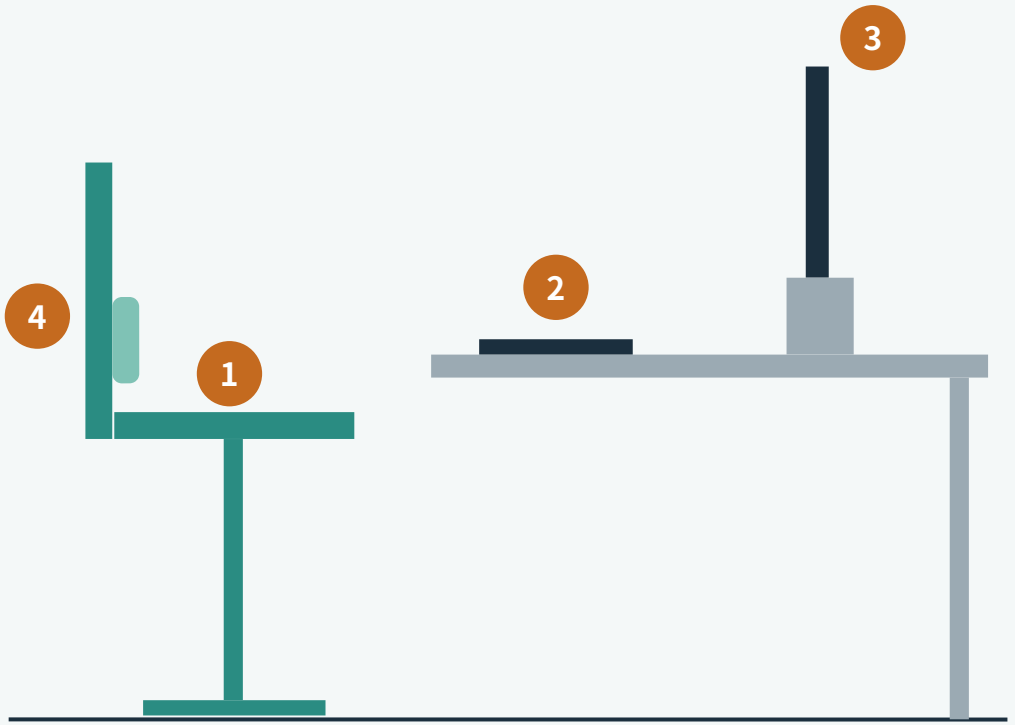
ボディメカニクスだけでは解決しない

持ち上げ方の指導単独では腰痛予防効果が示されていない。作業条件そのものを変える

出典：厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針及び解説」別紙IV (2013) ／ Verbeek JH et al. Cochrane Database Syst Rev 2011

記録・パソコン作業：機器を身体に合わせ、姿勢を固定し続けない

椅子・机・画面の位置関係（側面の概念図）



人物は描かず、機器の位置だけを示しています

番号・項目	目安	根拠の種類
1 座面	足裏全体が床に着く高さ。届かなければ足台	公的指針（腰痛予防対策指針）
2 机・入力機器	肘の曲げ角度がおよそ 90 度。キーボードは手前に	公的指針（腰痛予防対策指針）
3 画面	視距離おおむね 40cm 以上。上端は目の高さとほぼ同じかやや下	公的ガイドライン（情報機器作業 GL ）
4 背もたれ	深く腰掛け、背もたれで体幹を支える	公的指針（腰痛予防対策指針）
連続作業	一連続 1 時間を超えない。次までに 10 〜 15 分の作業休止、途中に 1 〜 2 回の小休止	公的ガイドライン（情報機器作業 GL ）
姿勢の変化	20 〜 30 分を目安に立つ・姿勢を変える	**研修上の実践例（最適な間隔の根拠は確立していない）**

出典：厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針」本文 2(2) ・別紙III (2013) ／厚生労働省「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」 (2019 、 2021 一部改正)

訪問・運転・記録が連続する一日を、負担の種類で見直す

朝
事務所で記録・連絡
座位の静的保持

移動
運転・乗り降り
姿勢拘束・振動
乗降時のひねり

訪問
床座り・低い座卓での面談
前傾の保持
立ち上がりの反復

移動
車内で記録・資料の出し入れ
前かがみ・ねじれ
片手での持ち運び

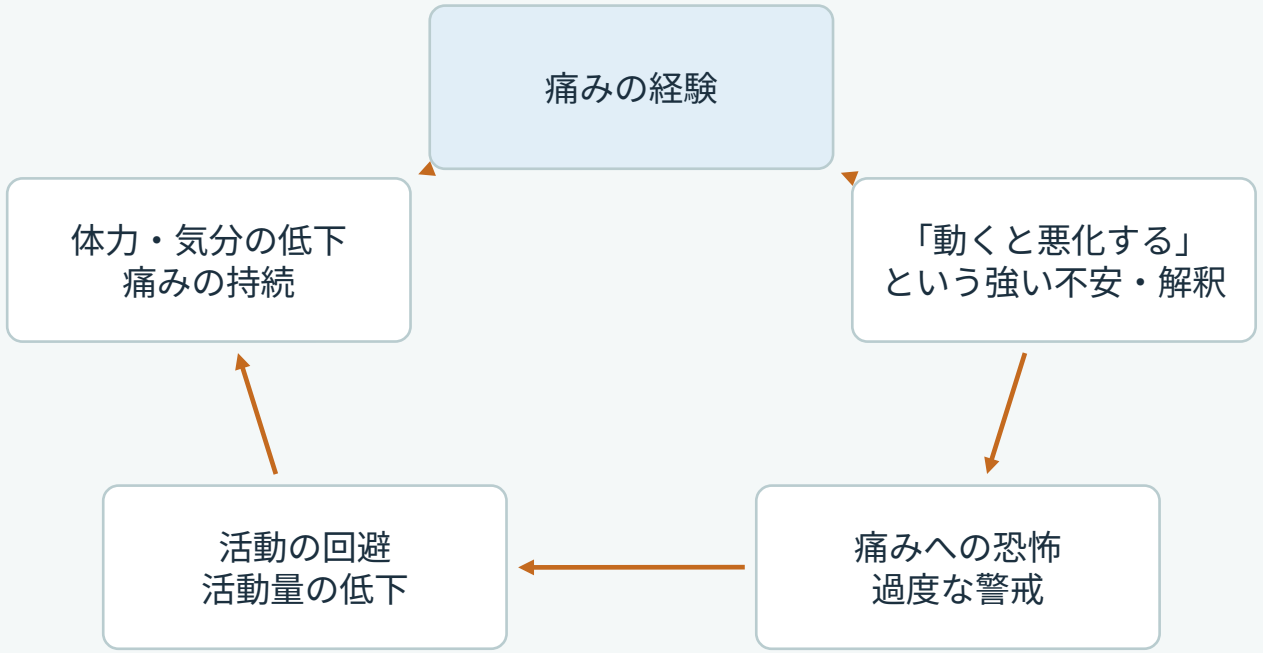
夕方
帰所後のまとめ記録
疲労が蓄積した状態での長時間座位

場面	評価すること	対策を選ぶ根拠
床座り・低い机	面談時間、座り方を変えられるか、膝・股関節の状態、椅子の使用が利用者の意向に合うか	指針は床の座作業をできる限り避け、やむを得ない場合は座布団を折って臀部を高くし、適宜立ち上がるとしている
運転・乗り降り	連続運転時間、座席・背もたれの調整、乗降時に身体をひねっていないか	座席を体格に合わせて調整し、乗降はお尻から座って両脚をそろえて回すなど、ひねりを減らす
資料の持ち運び	鞄の重さと持ち方（片手・片肩）、車からの出し入れの姿勢、運転直後か	荷を身体に近づけ左右の偏りを減らす。指針は長時間運転の直後に重い物を扱わず、休止後に行うとしている

出典：厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針及び解説」別紙Ⅰ・Ⅲ・Ⅴ (2013)

痛みへの不安と活動低下が、痛みを長引かせることがある

恐怖回避モデル（ Vlaeyen & Linton 2000 をもとに簡略化）



不安が強くない場合：痛みがあっても段階的に活動を続け、回復に向かいやすい

睡眠・疲労・仕事上のストレス

- 睡眠不足・疲労・仕事上のストレスは腰痛と関連する。ただし多くは関連の報告で、どちらが原因かは一方向に決められない
- 痛みで眠れない → 疲労で痛みに敏感になる、という双方向の関係もありうる
- 心理・社会的要因は、個人のストレス対処だけに頼らず、組織として業務量・相談体制・休みやすさで対応する

「気の持ちよう」という意味ではありません。痛みは実際に生じており、本人の責任ではありません。

出典： Vlaeyen JWS, Linton SJ. Pain 2000;85:317-32 ／厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針及び解説」 (2013) ／ Hartvigsen J et al. Lancet 2018

運動は有用な手段の一つ。ただし万能ではない

取組	研究・指針が示していること	限界・注意
運動＋教育	腰痛エピソードの予防に効果がある可能性（中等度の確実性）	効果は 1 年を超えると小さくなる。継続が前提
運動のみ	腰痛エピソード・病欠の予防に効果がある可能性（低〜非常に低い確実性）	1 年を超えると効果がみられなくなった
教育のみ	予防効果はみられなかった（中等度の確実性）	知識の提供だけでは行動・環境が変わらない
腰部ベルト	予防効果はみられなかった（低い確実性）。指針も一律の使用は勧めない	使う場合は個人ごとに効果を確認し、必要に応じ医師に相談
慢性腰痛への運動療法	国内外の診療ガイドラインが治療の選択肢として位置づける	特定の体操が優れるという一貫した根拠は乏しい。急性期・症状がある場合は医師と相談

この研修での位置づけ

- 運動は「作業条件の改善」の代わりにはならない
- 腰痛予防体操（ストレッチ）は、筋疲労の回復・柔軟性・リラクセーションを目的とする（指針）
- 痛みがあっても、医師の判断の範囲で日常の活動を保つことが勧められている
- 「この体操で必ず治る」「筋力不足が原因」とは言えない

出典： Steffens D et al. JAMA Intern Med 2016;176:199-208 ／ WHO guideline on chronic primary low back pain (2023) ／腰痛診療ガイドライン 2019 ／腰痛予防対策指針 (2013)

見逃したくないサインと、予防教育の境界

すぐに医療機関へ（救急を含む）

- 尿が出にくい・漏れる、便失禁などの排尿・排便の異常
- 肛門・会陰部（股の間）の感覚が鈍い
- 両脚のしびれや脱力が急に出る・進む

早めに受診・医療相談を

- 発熱を伴う、安静にしていても・夜間も続く痛み
- 転倒・転落などの外傷後（特に骨粗しょう症・ステロイド長期使用）
- がんの既往、説明できない体重減少
- 片脚のしびれ・筋力低下が続く、痛みが徐々に強くなる

レッドフラッグの意味

- 重い病気を「疑う手がかり」であり、診断を確定するものではない
- 単独の項目では診断の精度が限られる。複数の情報を組み合わせて医師が判断する

一般的な予防教育と個別の診療の境界

この研修で扱う	医師・産業医等が行う
負担の仕組み、作業条件の評価、予防の考え方、受診の目安	原因の診断、画像の解釈、治療、運動療法の処方、就業可否・業務制限の判断

職員同士で診断や治療を代わりに行わず、上長に相談して業務を調整します。

出典：腰痛診療ガイドライン 2019 ／ Downie A et al. BMJ 2013;347:f7095 ／ Finucane LM et al. JOSPT 2020;50:350-72 ／腰痛予防対策指針 (2013)

事例 A　片麻痺のある利用者の移乗と陰部洗浄

状況（研修用の架空事例）

利用者	80 代男性。脳梗塞後の右片麻痺。端座位は手すりがあれば数分保てるが、立位は不安定。指示はおおむね理解できる
医療・皮膚	尿道カテーテル留置。仙骨部に消えない発赤がある
環境	6 畳の和室に介護用ベッド。高さ調整は可能だが家族は最も低い位置で使用。片側は家具で狭い。車いすは肘掛け固定式
家族	妻（ 80 代）と二人暮らし。妻も腰痛がある
職員と作業	看護師 1 名で訪問（この日 5 件目、腰痛の既往あり）。通院準備のための車いす移乗と、陰部洗浄を行う

検討する問い

- **Q1**　どの条件が腰部負担を増やしているか
- **Q2**　追加で何を評価する必要があるか
- **Q3**　どの方法・用具を選ぶか
- **Q4**　その選択の根拠と限界は何か

出典：研修用に作成した架空事例。判断の根拠は厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針及び解説」別紙IV (2013)

事例 A　解説：条件によって選択は変わる

追加評価の結果（条件）	選ぶ方法・用具	根拠	限界・注意
端座位が安定し、非麻痺側で体重移動できる。跳ね上げ式肘掛けの車いすに変更できる	**スライディングボードで座位のまま横移動**	座位保持が可能ならボードを検討（指針）。持ち上げを水平移動に置き換える	車いすの変更・用具の手配に時間がかかる。発赤部をこすらない手順が必要
端座位が短時間しか保てない、または体格差が大きく協力が不安定	**リフトの導入をケアマネ・福祉用具専門相談員と検討**	座位・立位の保持が難しい場合はリフト。人力の抱え上げは原則行わない（指針）	和室のスペース・設置可否、家族の操作習熟。導入までの移乗は通院日の調整や人員で対応
どの条件でも共通（陰部洗浄・ベッド上の作業）	**作業時はベッドを上げ、終了後に戻す。ルートを先に整え、シートで位置調整**	前屈と d を減らす。動作中の不意な姿勢を防ぐ	家具の移動は家族の了解が必要。作業後の高さ戻し忘れは転落リスク

立位が不安定な状態での「立たせて回る」移乗や、看護師 1 名での抱え上げは選ばない。職員の腰痛既往も配置・訪問順の判断材料として事業所で共有する。

出典：厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針及び解説」本文 2(3) ・別紙IV (2013)

事例 B　訪問と記録が続くケアマネジャーの一日

状況（研修用の架空事例）

職員	50 代のケアマネジャー。最近、夕方になると腰の重だるさがある。下肢症状はない。月末は睡眠時間が短い
訪問	1 日 3 〜 4 件。床座りの和室で低い座卓を囲む面談が多く、1 件 45 〜 60 分
移動	社用の軽自動車で移動。車内で記録や資料の整理をすることが多い
事務所	ノート PC を机に直置き。椅子は座面高を調整できない会議用椅子。月末は給付管理で長時間入力
持ち物	利用者ファイルと PC を入れた重い鞄を片手で持つ

検討する問い

- **Q1**　どの条件が腰部負担を増やしているか
- **Q2**　追加で何を評価する必要があるか
- **Q3**　どの方法・環境調整を選ぶか
- **Q4**　その選択の根拠と限界は何か

出典：研修用に作成した架空事例。根拠は腰痛予防対策指針 (2013) 、情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン (2019)

事例 B　解説：個人の工夫と組織の対策を分けて考える

条件	選ぶ方法・環境調整	根拠	限界・注意
事務所の PC 作業：ノート PC 直置き、調整できない椅子	**外付けキーボードと PC スタンド。足台・腰当て。座面調整できる椅子への更新を検討**	肘約 90 度・足裏が床・画面上端は目の高さかやや下（指針・情報機器 GL ）	備品更新は事業所の判断と予算が必要。代替策は暫定
床座りの面談が長い。利用者は椅子を好まない	**座布団を折って臀部を高く。座り方を途中で変え、資料は手元に**	床の座作業は避けるのが原則、やむを得ない場合の方法（指針）	椅子を持参するかは利用者の意向が優先。膝・股関節の状態で方法が変わる
車内での記録、運転直後の持ち運び	**記録は停車して座席を戻してから、またはタブレットで後日入力。鞄は両肩・キャリーに**	ねじれと前かがみの保持を減らす。運転直後の荷扱いを避ける（指針）	職業運転向けの指針内容を短距離運転に一般化しない
月末の長時間入力、睡眠不足	**入力業務の平準化、連続作業の区切り、相談しやすい体制**	連続 1 時間以内と作業休止（情報機器 GL ）。心理社会的要因への組織対応（指針）	睡眠と腰痛は関連であり、因果は一方向に断定できない

重だるさが続く・強まる、下肢症状や排尿の異常が出る場合は、作業の工夫ではなく受診・医療相談を優先する。

出典：腰痛予防対策指針 本文 2(2) ・別紙III・ V (2013) ／情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン (2019 、 2021 一部改正)

理解度確認（１）画像所見の解釈と作業条件の選択

問１　腰痛のない職員が、健診の MRI で「椎間板の変性」を指摘された。最も適切な理解はどれか。

A　変性がある以上、介助業務は控えるべきである
B　無症状でも年齢とともに多くみられる所見であり、症状・機能と合わせて解釈する
C　今後の腰痛の原因が椎間板であると確定した
D　画像所見に臨床的な意味はまったくない

正解：B
理由：無症状者でも椎間板の変性は加齢とともに高い割合でみられ、医師が症状・診察所見と合わせて解釈する。
誤答の問題点：A は所見だけで就業を制限している。C は画像と痛みを同一視している。D は神経症状と一致する所見など重要な所見の存在を無視した過度な一般化。

問２　低いベッドで、前屈したまま陰部洗浄を毎回数分間行っている。腰部負担を下げる根拠が最も明確な対策はどれか。

A　下腹部に力を入れるよう意識して同じ方法で続ける
B　ベッドを大腿上部〜腰上部付近まで上げ、物品を手前に置く
C　できるだけ素早く終わらせる
D　職員全員が腰部ベルトを着用する

正解：B
理由：前屈角度と手を伸ばす距離（d）を同時に減らし、上半身と荷重によるモーメントを小さくする。指針もベッドの高さ調整を示す。
誤答の問題点：A は作業条件が変わらない。C は急な動作が想定外の負荷を生み、ケアの質も下げる。D は予防効果が示されておらず、指針も一律の使用を勧めない。

出典：Brinjikji W et al. AJNR 2015 ／腰痛予防対策指針及び解説 (2013) ／ Steffens D et al. JAMA Intern Med 2016

理解度確認（２）用具の適応判断と慢性化への理解

問３　端座位は安定しているが立位は保てない利用者。指示は理解できる。車いすは肘掛け固定式。最も妥当な判断はどれか。

A　職員２人で抱え上げれば腰の負担はなくなる
B　跳ね上げ式肘掛けの車いすへの変更を検討し、スライディングボードの適応を評価する
C　スライディングシートだけで車いすへ移す
D　立位補助機器で立たせて移乗する

正解：B

理由：座位保持が可能ならボードを検討（指針）。ただしボード移乗には肘掛けを外せる・跳ね上げられる車いすが必要で、用具と環境をセットで評価する。

誤答の問題点：A は二人でも前屈・身長差による負担が残る。C はシートの役割（ベッド上の摩擦軽減）と合わない。D は立位保持ができることが前提。

問４　３か月腰痛が続く同僚が「動くと悪化しそうで、休日はずっと横になっている」と話す。最も適切な対応はどれか。

A　気の持ちようなので、気にしないよう伝える
B　筋力不足が原因なので、自分で筋トレを指導する
C　受診や相談を勧め、職場として業務調整と相談体制を整える
D　痛みが完全になくなるまで安静を続けるよう勧める

正解：C

理由：慢性腰痛では恐怖回避と活動低下の悪循環が関わりうる。評価と治療は医療機関で行い、職場は心理社会的要因に組織として対応する。

誤答の問題点：A は痛みを本人の責任にしている。B は原因の断定と職員同士の治療になる。D は活動低下を強め、安静が有効との根拠も乏しい。

出典：腰痛予防対策指針及び解説 (2013) ／ Vlaeyen & Linton. Pain 2000 ／腰痛診療ガイドライン 2019

この研修で押さえておきたい重要事項

1

腰痛は多要因

痛む場所や画像所見だけで原因組織は決まらない。身体・環境・心理社会の要因が重なる

2

負担は作業条件の組み合わせ

荷重・距離・姿勢・時間・頻度・支持をセットで評価し、姿勢だけで良し悪しを決めない

3

d を短く、前屈と回旋を減らす

作業面の高さ、立ち位置、物品の配置で、モーメントそのものを小さくする

4

人を持ち上げない

全介助の人力の抱え上げは原則避け、機能と環境に応じて用具を選ぶ

5

用具・二人介助・技術にも限界

適合と習熟が前提。二人介助でも負担は残り、技術指導だけでは予防できない

6

座り続けることも負担

機器を身体に合わせ、姿勢を変えられる環境と業務の区切りを作る

7

慢性化には心理社会的要因

恐怖回避・睡眠・ストレスは関連要因。本人の責任にせず組織で対応する

8

サインを見逃さない

排尿・排便の異常、進む神経症状、発熱、外傷後は受診。予防教育は診療の代わりではない

出典：本研修の各スライドに示した出典のまとめ（次ページの参考文献を参照）

参考文献（資料名・発行主体・発行年・ URL ）

1. 厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針及び解説」 2013 （基発 0618 第 1 号）
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/youtsuushishin.html

2. 厚生労働省「腰痛予防対策」（関連資料一覧）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31158.html

3. 厚生労働省「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」 2019 （ 2021 一部改正）
https://www.mhlw.go.jp/content/000539603.pdf

4. 日本整形外科学会・日本腰痛学会監修「腰痛診療ガイドライン 2019 改訂第 2 版」南江堂 2019
https://minds.jcqhc.or.jp/summary/c00498/

5. WHO. Guideline for non-surgical management of chronic primary low back pain in adults in primary and community care settings. 2023
https://www.who.int/publications/i/item/9789240081789

6. 経済産業省「健康経営優良法人認定制度」
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html

7. 岩切一幸 , 佐々木毅 , 三木圭一 . 2018 年及び 2019 年労働者死傷病報告における業務上腰痛の発生状況 . 産業衛生学雑誌 2022;64(6):354-366
https://doi.org/10.1539/sangyoeisei.2021-038-E

8. Hartvigsen J, et al. What low back pain is and why we need to pay attention. Lancet 2018;391:2356-67
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)30480-X

9. Foster NE, et al. Prevention and treatment of low back pain: evidence, challenges, and promising directions. Lancet 2018;391:2368-83
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)30489-6

10. Brinjikji W, et al. Systematic literature review of imaging features of spinal degeneration in asymptomatic populations. AJNR Am J Neuroradiol 2015;36:811-6
https://www.ajnr.org/content/36/4/811

11. Suzuki H, et al. Diagnosis and characters of non-specific low back pain in Japan: the Yamaguchi Low Back Pain Study. PLoS One 2016;11:e0160454
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0160454

12. Wilke HJ, et al. New in vivo measurements of pressures in the intervertebral disc in daily life. Spine 1999;24:755-62
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10222525/

13. Waters TR. When is it safe to manually lift a patient? Am J Nurs 2007;107(8)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17667392/

14. Verbeek JH, et al. Manual material handling advice and assistive devices for preventing and treating back pain in workers. Cochrane Database Syst Rev 2011;(6):CD005958
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21678349/

15. Steffens D, et al. Prevention of low back pain: a systematic review and meta-analysis. JAMA Intern Med 2016;176:199-208
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2481158

16. Vlaeyen JWS, Linton SJ. Fear-avoidance and its consequences in chronic musculoskeletal pain: a state of the art. Pain 2000;85:317-32
https://doi.org/10.1016/S0304-3959(99)00242-0

17. Downie A, et al. Red flags to screen for malignancy and fracture in patients with low back pain: systematic review. BMJ 2013;347:f7095
https://doi.org/10.1136/bmj.f7095

18. Finucane LM, et al. International framework for red flags for potential serious spinal pathologies. J Orthop Sports Phys Ther 2020;50:350-72
https://doi.org/10.2519/jospt.2020.9971

URL は 2026 年 10 月の作成時に所在を確認したものです。行政資料は改訂・移動されることがあるため、利用時に最新版を確認してください。